BONUS 3

Vizitte Vaka Sunumu Şablonları

60 ve 120 saniyelik sunum yapısı, vaka tipine göre 8 şablon, vizitte işinize yarayacak hazır cümleler ve baştan sona 6 örnek sunum.

İçindekiler

Bu şablonlar nasıl kullanılır

Bölüm 1 · 60 saniyelik sunum

Bölüm 2 · 120 saniyelik sunum

Bölüm 3 · Vaka tipine göre 8 şablon

Bölüm 4 · Vizitte işe yarayan cümleler

Bölüm 5 · 6 örnek sunum

Bölüm 6 · Sunum öncesi son kontrol

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bu şablonlar nasıl kullanılır

İyi bir vaka sunumu, iyi bir raporun sesli halidir: aynı sıra, aynı netlik.

> *Vizitte sizi zorlayan çoğu zaman bilgi eksikliği değil, sıranın kaybolmasıdır. Şablon sırayı sizin yerinize tutar; siz bulguya odaklanırsınız.*

Sunum, rapor yazarken kullandığınız **4 adımlı metodun** aynısıdır:

ADIM	SUNUMDA KARŞILIĞI
1 · HAZIRLA	Hasta (yaş, cinsiyet), klinik soru, tetkik ve protokol, teknik yeterlilik.
2 · TARA	«Sistematik olarak değerlendirdim» cümlesi; hangi bölgelere baktığınızı kısaca belirtin.
3 · TANIMLA	Ana bulgu: doğru terim, yer, boyut, sınır; önceki tetkikle karşılaştırma. Ardından eşlik eden bulgular.
4 · ÖZETLE	Tek cümlelik sonuç, ayırıcı tanı, öneri; acil bulgunun kime ve ne zaman bildirildiği.

Üç altın kural

1. **Sonucu sona saklamayın.** 60 saniyelik sunumda bile ilk cümlede klinik soruyu, son cümlede net sonucu söyleyin.
2. **Görüntüyü gösterirken konuşun.** Bulguyu tarif ederken ekranda o kesiti açık tutun ve işaret edin.
3. **Bilmediğinizi uydurmayın.** «Bundan emin değilim, uzman hocamla birlikte değerlendirmek isterim» demek profesyonelliktir.

Pratik

Her şablonu önce yüksek sesle, saat tutarak üç kez deneyin. Pratik Defteri'ne kendi sürenizi yazın; hedef, 60 saniyelik sunumu 60 saniyenin altında bitirmektir.

BÖLÜM 1

60 saniyelik sunum

Nöbet devri, koridor vizit, «kısaca anlat» denildiğinde.

SÜRE	NE SÖYLERSİNİZ
0–10 sn · Kimlik ve soru	«[Yaş] yaşında [kadın/erkek] hasta, [şikâyet/klinik soru] nedeniyle [tetkik] çekildi.»
10–15 sn · Teknik	«Tetkik tanısal kalitede.» veya «[Kısıtlılık] nedeniyle değerlendirme sınırlı.»
15–40 sn · Ana bulgu	«[Yer]de [boyut], [sınır], [dansite/sinyal/ekojenite] [bulgu] izleniyor. Önceki tetkike göre [değişim].»
40–50 sn · Eşlik eden	«Eşlik eden [bulgu] var / yok. [Önemli negatif] izlenmedi.»
50–60 sn · Sonuç	«Sonuç olarak [tanı] ile uyumlu; ayırıcı tanıda [1–2 tanı]. [Öneri]. [Klinik ekibe bildirildi].»

Kısa kalmanın sırrı

60 saniyede yalnızca bir ana bulgu ve en fazla iki önemli negatif söyleyin. Gerisini, soru gelirse açın.

BÖLÜM 2

120 saniyelik sunum

Sabah viziti, vaka toplantısı, uzman hocanızın «baştan anlat» dediği an.

SÜRE	NE SÖYLERSİNİZ
0–15 sn · Kimlik ve klinik	Yaş, cinsiyet, şikâyet ve süresi, ilgili özgeçmiş, klinik soru.
15–25 sn · Tetkik ve teknik	Modalite, kontrast ve faz (veya sekanslar), teknik yeterlilik, önceki tetkiklerin varlığı.
25–35 sn · Tarama	«Sistematik olarak [bölgeleri] değerlendirdim.»
35–75 sn · Ana bulgu	Doğru terimle tam tarif: yer, boyut (iki veya üç düzlem), sınır, iç yapı, kontrastlanma; karşılaştırma.
75–90 sn · Eşlik eden ve negatifler	Komplikasyonlar, eşlik eden bulgular, klinik soruyla ilgili önemli negatifler.
90–110 sn · Sonuç ve ayırıcı tanı	Bir cümlelik sonuç; ayırıcı tanıda neden önce bunu düşündüğünüz.
110–120 sn · Öneri ve iletişim	İleri tetkik veya takip önerisi; acil bulgu ise kime, ne zaman bildirildiği.

Sık hata

120 saniyelik sunumda en çok zaman tarama cümlesinde kaybedilir. Normal organları tek tek saymayın: «Diğer solid organlar olağan» demeniz yeterlidir; klinik soruyla ilgili önemli negatifleri ise ayrıca söyleyin.

BÖLÜM 3

Vaka tipine göre 8 şablon

Boşlukları doldurun, sırayı değiştirmeyin.

ŞABLON 1

Acil bulgu (kanama, pnömotoraks, serbest hava gibi)

1. «Acil bir bulgu ile başlıyorum: [bulgu].»
2. Hasta, klinik soru, tetkik.
3. Bulgunun yeri, boyutu ve etkisi (kitle etkisi, şift, kollaps gibi).
4. Komplikasyon ve eşlik eden bulgular.
5. «[Saat]te [klinik ekip/hekim] bilgilendirildi.»

ŞABLON 2

Normal tetkik

1. Hasta, klinik soru, tetkik ve teknik yeterlilik.
2. «Sistematik değerlendirmede patolojik bulgu saptamadım.»
3. Klinik soruya yönelik önemli negatifler (ör. «kanama, kitle etkisi ve kırık izlenmedi»).
4. Tetkikin sınırlılığı varsa belirtin (ör. erken iskemi kontrastsız BT'de görünmeyebilir).
5. Gerekirse öneri.

ŞABLON 3

Kitle / lezyon

1. Hasta, klinik soru, tetkik ve kontrast fazları.
2. Lezyonun yeri, boyutu, sınırı, iç yapısı, kontrastlanma davranışı.
3. Komşu yapılarla ilişkisi, invazyon bulguları.
4. Lenf nodları ve uzak bulgular.
5. Ayırıcı tanı (en olasıdan başlayarak) ve ileri tetkik önerisi.

ŞABLON 4

Enfeksiyon / inflamasyon

1. Hasta, klinik (ateş, ağrı, laboratuvar varsa), tetkik.
2. Ana inflamatuvar bulgu: yer, yaygınlık.
3. Komplikasyon: apse, perforasyon, obstrüksiyon, yayılım.
4. Ayırıcı tanı.
5. Öneri (drenaja uygun koleksiyon var mı, takip gerekiyor mu).

ŞABLON 5

Travma

1. Hasta, travma mekanizması, tetkik.
2. En ciddi yaralanma önce (hayatı tehdit eden bulgu).
3. Diğer yaralanmalar, sistematik sırayla (baştan aşağı veya organ organ).
4. Önemli negatifler (ör. «aktif kontrast kaçışı izlenmedi»).
5. Bildirim ve öneri.

ŞABLON 6

Takip tetkiki (karşılaştırmalı)

1. Hasta, bilinen tanı, önceki tetkikin tarihi ve modalitesi.
2. Bilinen lezyonun bugünkü ölçüsü ve öncekine göre değişimi (aynı yöntemle ölçülmüş).
3. Yeni gelişen bulgu var mı.
4. Genel değerlendirme: gerileme, stabil, ilerleme.
5. Öneri.

ŞABLON 7

Tüp / kateter / cihaz kontrolü

1. Hasta, tetkik, kontrol edilen cihaz(lar).
2. Her cihazın ucu nerede; beklenen pozisyonda mı.
3. Cihaza bağlı komplikasyon (pnömotoraks, malpozisyon, kıvrılma).
4. Önceki grafiye göre değişim.
5. Pozisyon uygun değilse bildirim.

ŞABLON 8

Rastlantısal bulgu

1. Klinik soru ve onun cevabı önce.
2. «Ayrıca rastlantısal olarak [bulgu] izlendi.»
3. Bulgunun tarifi.
4. Klinik önemi ve servisinizin kullandığı takip yaklaşımına göre öneri.
5. Önceki tetkiklerde var mıydı.

BÖLÜM 4

Vizitte işe yarayan cümleler

Doğru cümle, doğru güven düzeyini taşır.

DURUM	KULLANABİLECEĞİNİZ CÜMLE
Açılış	«[Yaş] yaşında [kadın/erkek] hasta; [klinik soru] nedeniyle [tetkik] çekildi.»
Teknik kısıtlılık	«Hareket artefaktı nedeniyle [bölge] değerlendirmesi sınırlı.»
Karşılaştırma	«[Tarih]li [tetkik] ile karşılaştırıldığında [bulgu] [boyut/görünüm] olarak [arttı/azaldı/değişmedi].»
Önceki tetkik yok	«Karşılaştırma için önceki tetkik mevcut değil.»
Yüksek güven	«... ile uyumlu.»
Orta güven	«... lehine; ayırıcı tanıda ... düşünülebilir.»
Düşük güven	«... dışlanamamaktadır.»
Önemli negatif	«Klinik soru açısından ... izlenmedi.»
Öneri	«... açısından [tetkik] ile değerlendirme önerilebilir.»
Bildirim	«Bulgu [saat]te [ilgili hekim] ile paylaşıldı.»
Bilmediğiniz soru	«Bu konuda emin değilim; okuyup yarınki vizitte size döneceğim.»
Hocanız farklı düşünüyorsa	«Ben ... nedeniyle ... düşünmüştüm; sizin ... bulgusunu nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek isterim.»
Zaman daraldığında	«Kısaca: ... ile uyumlu, ... bildirildi. Ayrıntıları göstermemi ister misiniz?»
Kapanış	«Sonuç olarak ...; önerim ....»

Kaçınılacak ifadeler

- «Galiba bir şey var» — bulguyu ve yerini söyleyin.
- «Normal gibi» — ya normaldir ya da kısıtlılığı söyleyin.
- «Hafif», «belirgin» (ölçüsüz) — ölçü verin.
- «Tümör» (doku tanısı yokken) — «kitle» veya «kitle lezyonu» deyin.
- MR'da «dansite», USG'de «opasite» — modaliteye ait terimi kullanın.

BÖLÜM 5

6 örnek sunum

Tüm vakalar kurgusaldır; yalnızca sunum yapısını göstermek için hazırlanmıştır.

ÖRNEK 1 · 60 SANİYE · ŞABLON 1

Travma sonrası beyin BT

«Acil bir bulgu ile başlıyorum: **akut subdural hematom**.

Yetmiş iki yaşında erkek hasta, evde düşme sonrası bilinç bulanıklığı nedeniyle kontrastsız beyin BT çekildi. Tetkik tanısal kalitede.

Sol frontoparyetal konveksite boyunca, kafatası iç tablasına paralel uzanan, hilal şeklinde hiperdens ekstraaksiyel koleksiyon izleniyor. Sol lateral ventrikülde bası ve sağa doğru orta hat şifti mevcut.

Kemik penceresinde kırık saptamadım. Eşlik eden parankimal kanama izlenmedi.

Sonuç olarak kitle etkisi oluşturan akut subdural hematom ile uyumlu. Bulgu saat 03.10'da acil servis hekimi ile paylaşıldı.»

ÖRNEK 2 · 60 SANİYE · ŞABLON 7

Yoğun bakım akciğer grafisi

«Altmış beş yaşında kadın hasta, entübasyon sonrası tüp kontrolü için yatak başı AP akciğer grafisi çekildi. Hafif rotasyon mevcut, değerlendirme için yeterli.

Endotrakeal tüpün ucu karina düzeyinin hemen üzerinde; servisimizin beklediği pozisyondan daha distalde. Sağ juguler santral venöz kateterin ucu superior vena kava düzeyinde. Nazogastrik tüp diyafram altına uzanıyor.

Pnömotoraks izlenmedi. Önceki grafiye göre yeni konsolidasyon yok.

Sonuç olarak endotrakeal tüp distal yerleşimli; geri çekilmesi açısından değerlendirme önerilir. Yoğun bakım hekimine bildirildi.»

ÖRNEK 3 · 120 SANİYE · ŞABLON 4

Sağ alt kadran ağrısı, batın BT

«Yirmi sekiz yaşında erkek hasta, iki gündür süren sağ alt kadran ağrısı ve ateş ile başvurdu; klinik soru akut apandisit. Portal venöz fazda kontrastlı batın-pelvis BT çekildi; önceki tetkik yok. Tetkik tanısal kalitede.

Batını sistematik olarak değerlendirdim: serbest hava, solid organlar, barsaklar, damarlar ve pelvis.

Apendiks çapı artmış, duvarı kalınlaşmış ve kontrastlanıyor. Lümende apendikolit ile uyumlu hiperdens odak var. Periapendiküler yağ dokusunda kirlenme ve az miktarda serbest sıvı izleniyor.

Apse ile uyumlu koleksiyon ve serbest hava saptamadım. Terminal ileum ve çekum duvarı olağan. Sağ böbrek ve üreter seyri olağan, taş izlenmedi.

Sonuç olarak **komplike olmayan akut apandisit** ile uyumlu. Ayırıcı tanıda çekal divertikülit ve terminal ileit düşünülebilir, ancak bulgular apendiks merkezlidir.

Bulgu genel cerrahi asistanı ile paylaşıldı.»

ÖRNEK 4 · 120 SANİYE · ŞABLON 3

Toraks BT'de akciğer kitlesi

«Altmış sekiz yaşında erkek hasta, uzun süreli sigara öyküsü ve üç aydır süren öksürük ile başvurdu; akciğer grafisinde opasite saptanması üzerine kontrastlı toraks BT çekildi. Karşılaştırma için yalnızca bir ay önceki akciğer grafisi mevcut.

Akciğer ve mediasten pencerelerinde sistematik değerlendirme yaptım.

Sağ akciğer üst lobda düzensiz ve spiküle konturlu, heterojen kontrastlanan solid kitle izleniyor. Kitle grafideki opasite ile uyumlu. Plevraya uzanım şüphesi var; göğüs duvarı invazyonu belirgin değil.

Sağ hiler ve alt paratrakeal bölgede boyutları artmış lenf nodları mevcut. Sol akciğerde nodül saptamadım. Kesit alanına giren sürrenaller ve karaciğer olağan; kemiklerde litik lezyon izlenmedi.

Sonuç olarak **primer akciğer malignitesi lehine** kitle ve hiler-mediastinal lenfadenopati. Doku tanısı ve evreleme için ileri değerlendirme önerilir.

Raporu uzman hocamla birlikte kesinleştirmek istiyorum.»

ÖRNEK 5 · 60 SANİYE · ŞABLON 2

Baş ağrısı, normal beyin BT

«Kırk yaşında kadın hasta, bir haftadır süren baş ağrısı nedeniyle kontrastsız beyin BT çekildi. Tetkik tanısal kalitede.

Sistematik değerlendirmede patolojik bulgu saptamadım.

Kanama, kitle etkisi ve orta hat şifti izlenmedi. Ventriküller ve sisternler olağan. Gri-beyaz cevher ayrımı korunmuş. Kemik penceresinde patoloji yok; sinüsler havalı.

Kontrastsız BT'nin bazı patolojileri göstermede sınırlı olduğunu biliyoruz; klinik şüphe devam ederse ileri tetkik klinik ekiple birlikte değerlendirilebilir.»

ÖRNEK 6 · 120 SANİYE · ŞABLON 6

Karaciğer lezyonu takibi

«Elli beş yaşında kadın hasta, kolon malignitesi nedeniyle opere; karaciğerde bilinen tek lezyon için takip amaçlı portal venöz fazda kontrastlı batın BT çekildi. Altı ay önceki BT ile karşılaştırdım. Tetkik tanısal kalitede.

Batını sistematik olarak değerlendirdim.

Karaciğer sağ lobdaki bilinen hipodens lezyon, önceki tetkiktekiyle aynı yöntem ve aynı kesitte ölçüldüğünde boyut olarak gerilemiş. Lezyonun sınırları ve iç yapısı belirgin değişmemiş.

Karaciğerde yeni lezyon saptamadım. Lenfadenopati, asit ve peritoneal implant ile uyumlu bulgu izlenmedi. Anastomoz hattı bölgesinde belirgin patoloji yok. Kesit alanına giren akciğer bazallerinde nodül izlenmedi.

Sonuç olarak bilinen karaciğer lezyonunda **boyutsal gerileme**; yeni lezyon yok. Önceki tetkike göre tedaviye yanıt lehine değerlendirilebilir.

Takip aralığı klinik ekibin planına göre belirlenebilir.»

BÖLÜM 6

Sunum öncesi son kontrol

Vizitten önce 2 dakikanızı ayırın.

Her sunumdan önce

- [ ] Hastanın yaşını, cinsiyetini ve klinik sorusunu tek cümlede söyleyebiliyorum.
- [ ] Tetkik, kontrast fazı veya sekanslar ve teknik yeterlilik notum hazır.
- [ ] Önceki tetkiki açtım ve karşılaştırdım (ya da olmadığını not ettim).
- [ ] Ana bulguyu gösterecek kesit ekranda hazır.
- [ ] Ana bulgu için doğru terimi (dansite / sinyal / ekojenite) kullanıyorum.
- [ ] Klinik soruyla ilgili en az iki önemli negatifim var.
- [ ] Tek cümlelik sonucum ve ayırıcı tanım hazır.
- [ ] Acil bulgu varsa kime ve ne zaman bildirildiğini biliyorum.
- [ ] Sunumu saat tutarak bir kez sessizce prova ettim.

Altın kural

Vizitte hocanızın aklında kalacak tek şey son cümlenizdir. Sonuç cümlenizi önceden yazın ve kelimesi kelimesine söyleyin.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi 100 Pratik Vaka'dan bir vaka seçin ve Şablon 1–8'den uygun olanla, saat tutarak 60 saniyelik bir sunum yapın.

Sunuma çıkacağınız soruları önceden çalışmak için **300 Vizit ve Sözlü Sınav Sorusu**'na geçin.